

Guide de facturation

CLSC - Tarif horaire

Pour nous rejoindre :

☎ 1 866 332-2638

🌐 www.facturation.net



Note : L'information contenue dans ce document peut être expirée ou incomplète. Toujours référer aux manuels de facturation de la RAMQ sur le site www.ramq.gouv.qc.ca.

Table des matières

NOMINATION	4
TARIF HORAIRE	4
ENTENTE PARTICULIERE - MEDECINS QUI EXERCENT DANS OU AUPRES D'UN CLSC (NO 17)	4
SECTEUR DE DISPENSATION A INDiquer POUR LES PROGRAMMES EN CLSC	5
SUPPLÉMENTS FACTURABLES AVEC TARIF HORAIRE	5
SANS RENDEZ-VOUS A L'ACTE (SRV)	5
Visite ponctuelle mineure	6
Visite ponctuelle complexe	6
Visite d'évaluation mineure	7
Visite d'évaluation complexe	7
L'Intervention clinique (raccourci I)	7
PROGRAMME DE SANTÉ MENTALE	10
AUTRES PRÉCISIONS	13
SECTEUR POUR LA FACTURATION A L'ACTE	13
ELEMENT DE CONTEXTE A L'ACTE	13
PLAGE HORAIRE A L'ACTE	14
MAJORATION APPLICABLE A L'ACTE	14
SYMBOLES UTILISE S POUR LES UTILISATEURS DU PLAN ELITE	14
DIAGNOSTICS	15
GARDE EN DISPONIBILITÉ – EP 38	15
SUIVI DE GROSSESSE	17
INSCRIPTION DE LA CLIENTÈLE	18
FORFAIT INSCRIPTION GENERALE	18
PATIENT SANS ME DECIN DE FAMILLE	18
SUPPLEMENT A L'EXAMEN PERIODIQUE D'UN ENFANT AGE DE 0 A 5 ANS	19
LA CLIENTELE VULNERABLE	20
TABEAU DES CONDITIONS DE VULNERABILITE	20
CATEGORIES DE PROBLEMES DE SANTE RETENUES	21
FORFAIT ANNUEL DE PRISE EN CHARGE POUR UN PATIENT VULNERABLE	22
LA GRANDE INSCRIPTION – LETTRE D'ENTENTE 321	23
RE TABLISSEMENT D'UNE INSCRIPTION	23
CONSERVATION DU FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUPRES D'UN ME DECIN DE FAMILLE	23
RETRAITE D'UN ME DECIN DE FAMILLE	23
ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ GMF (EP 33)	24
FORFAIT DE PRISE EN CHARGE ET DE SUIVI (RACCOURCI GMF)	24
REMUNERATION DU ME DECIN RESPONSABLE EN GMF	24
TARIF HORAIRE	24
INSCRIPTION EN GMF	25
PRATIQUE CLINIQUES RÉSEAUX GMF-R (EP 54)	27
DÉPLACEMENT D'URGENCE DE NUIT	27
MÉDECIN ENSEIGNANT	28
RESIDENT / EXTERNE	28

INFIRMIERE PRATICIENNE SPECIALISEE (IPS) - LETTRE D'ENTENTE 213	29
INTÉGRATION IPS-SPL ET CIPS-SPL – LETTRE D'ENTENTE 229	29
PATIENT INSCRIT PAR UNE IPSPL/CIPSPL	30
CNESST	31
FORMATION CONTINUE (annexe XIX)	33
SÉJOUR DE FORMATION (ANNEXE XII)	35
FACTURATION HORS-RAMQ	36
GUIDE DE FACTURATION PRIVÉE OMNIPRATICIEN	36
GRILLE PROVINCIALE DES TARIFS POUR LES SERVICES NON ASSURÉS, LES SERVICES DÉASSURÉS ET LES FRAIS CONNEXES EFFECTUÉS PAR DES MÉDECINS DE FAMILLE Ces tarifs sont suggérés par la FMOQ Les taxes exigibles sont en sus Pour obtenir la version la plus récente de cette grille :	
https://www.fmoq.org/pratique/facturation/frais-accessoires/grille-tarifaire-et-affichage-des-frais-admissibles/	38
ANNEXE 1 - FACTURATION D'UN DÉPLACEMENT	39
ANNEXE 2 – FACTURATION DU TARIF HORAIRE	42
ANNEXE 3 – PROCÉDURES POUR LE PLAN ELITE	45
CREATION D'UN PATIENT BEBE	45
CREATION DE PATIENTS BEBES Jumeaux	45
NUMERO D'ASSURANCE MALADIE EXPIRE OU PATIENT SANS NAM	46
FORFAIT SUPERVISION	50
AJOUT D'UN PROFESSIONNEL REFERANT	51

Le présent guide a été conçu pour que vous puissiez le consulter à l'écran ou sous format papier. Pour visualiser les différents sujets à l'écran, vous pouvez cliquer sur le sujet via la table des matières ou l'icône de Signet pour que la table des matières s'affiche à droite et facilite vos recherches. Veuillez utiliser le premier onglet pour consulter la table des matières. Par souci pour l'environnement, pensez à imprimer **recto-verso**.



NOMINATION

L'établissement doit faire parvenir à la Régie le formulaire **Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif horaire (3547)**

TARIF HORAIRE

 **Plan ELITE** : Vous retrouverez à l'annexe 2 la procédure pour faire votre demande de tarif horaire sur Facturation.net.

ENTENTE PARTICULIERE - MEDECINS QUI EXERCENT DANS OU AUPRES D'UN CLSC (NO 17)

Utiliser les codes d'activité suivants en remplaçant les X par les chiffres appropriés :

Dans un CLSC = **002XXX**

Dans le programme de soutien à domicile : **002404**

Dans le programme Toxicomanie = **263XXX**

Dans le programme Itinérance = **264XXX**

Dans le programme santé mentale = **276XXX (spécificités de ce programme précisées plus loin dans ce guide)**

Les codes d'activité sont les suivants :

- **XXX015** Examens relatifs à l'hépatite C
- **XXX030** Services cliniques *
- **XXX031** Étude de dossiers
- **XXX032** Rencontres multidisciplinaires
- **XXX037** Planification – Programmation – Évaluation
- **XXX043** Tâches médico-administratives et hospitalières (**secteur de dispensation : 0**)
- **XXX055** Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- **XXX063** Garde sur place
- **XXX071** Garde sur place à même les 35 premières heures d'activités professionnelles hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l'annexe XIV, aucune limitation d'heures (TH seulement).
- **XXX098** Services de santé durant le délai de carence
- **XXX414** Assemblée du CMDP
- **XXX415** Réunion de département
- **XXX416** Réunion de service
- **XXX417** Comité exécutif du CMDP
- **XXX418** Comité du CMDP (excluant le comité exécutif du CMDP)

PROGRAMME CENTRE DE DETENTION :

- 88030** Services dispensés dans un centre de détention à partir de la nomination du médecin dans un CLSC

PROGRAMME CENTRE ANTIPOISON :

- **89030** Services cliniques
- **89067** Expertise-conseil, information et coordination

* Pour la facturation des services cliniques effectués dans un GMF ou dans une clinique réseau, se référer aux ententes particulières concernées pour connaître le code d'activité à utiliser.

SECTEUR DE DISPENSATION A INDIQUER POUR LES PROGRAMMES EN CLSC

Périodes	Secteur	Majoration	PH
En semaine de 8h à 18h	1	n/a	AM ou PM
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h	23	16%	PM
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 20h à 22h	24	16%	SO
Vendredi de 18h à 20h	25	26%	PM
Vendredi de 20h à 22h	26	26%	SO
Samedi, dimanche et jours fériés de 8h à 24h	27	26%	AM, PM, ou SO
Samedi, dimanche et jours fériés de 8h à 24h (clinique réseau)	28	33%	AM, PM ou SO

SUPPLÉMENTS FACTURABLES AVEC TARIF HORAIRE

Supplément de vulnérabilité	15169
Forfait GMF prise en charge	8875
ABCdaire 0-5 ans	8877
Prise en charge de grossesse	15159
Transfert de grossesse GMF	19074
Transfert de grossesse	15189
Suivi de grossesse	15145
Supp. vuln. Domicile	15170

Patient sans médecin de famille (orphelin)	
Référé ou non- en santé	19957
Non référé - vulnérable	19958
Référé - vulnérable	19959
Référé - très vulnérable	19960
Référé ou non - vulnérable (+150 pts. Référé)	19965

CSNESST (la date d'événement est obligatoire)

Bilan verbal	9907	Attestation médicale	9926	Rapport final	9930
Assignment temporaire	9971	Lien d'emploi	9908	Prise en charge	9927
Rapport complémentaire	9909	Évolution	9928	Retrait préventif	9970

Ne pas oublier de facturer votre garde en disponibilité (EP38) s'il y a lieu ainsi que la supervision des résidents, externes (EP 42) et IPS_SPL (LE 229) qui sont aussi facturables lorsque vous être rémunéré à tarif horaire.

Voir leurs sections spécifiques vers la fin du guide pour l'information détaillée.

SANS RENDEZ-VOUS A L'ACTE (SRV)

Le médecin qui opte pour le mode des honoraires fixes ou celui du tarif horaire peut, au moment de sa nomination ou du renouvellement de sa nomination, choisir, sur recommandation du chef du service médical ou du médecin responsable et avec l'approbation de l'établissement, le mode de l'acte lorsqu'il exerce dans le cadre des services médicaux sans rendez-vous, dans le cadre du service d'urgence d'un centre local de services communautaires du réseau de garde ou dans le cadre du programme de maintien à domicile. Le médecin peut aussi opter pour le mode de l'acte lorsqu'il dispense des services médico-administratifs visés à l'annexe XIII de l'Entente.

AVIS : L'établissement doit préciser le mode de rémunération à l'acte sur l'avis de service si le médecin qui détient une nomination à tarif horaire ou à honoraires fixes choisit le mode de l'acte lorsqu'il effectue une ou des activités ci-haut mentionnées.

L'établissement doit également cocher tous les jours ou samedi, dimanche et jours fériés, s'il s'agit du service d'urgence ou de services médicaux sans rendez-vous.

Pour la facturation à l'acte, voici la liste des visites permises :

Visite ponctuelle mineure

Évaluation d'un **patient inscrit ou non pour un problème concernant un seul système ou une seule partie du corps**. Inclut questionnaire, l'examen lorsque requis, l'établissement d'un diagnostic et les recommandations.

Peut être répétée plus d'une fois par jour lorsque contact requis pour faire nouveau questionnaire ou examen, pour initier un traitement, évaluer un traitement en cours, observer l'évolution ou la réponse à un traitement

Le tarif est modulé selon que le patient est vulnérable ou non, que le médecin atteint ou non le seuil d'inscription de 500 patients ou plus et selon que le patient a moins de 80 ans ou 80 ans ou plus.

Codes	Patient inscrit ou non	ÂGE	Patients inscrits
15765	Non vulnérable	80 et -	500 et -
15766	Non vulnérable	80 et -	500 et +
15767	Vulnérable	80 et -	500 et -
15768	Vulnérable	80 et -	500 et +
15769	Non vulnérable	80 et +	500 et -
15770	Non vulnérable	80 et +	500 et +
15771	Vulnérable	80 et +	500 et -
15772	Vulnérable	80 et +	500 et +

Visite ponctuelle complexe

Évaluation d'un **patient inscrit ou non pour un problème concernant plus d'un système ou plus d'une région du corps**. Inclut questionnaire, l'examen, l'établissement d'un diagnostic et les recommandations.

Peut-être facturé plus d'une fois par jour pour un même patient lorsqu'un contact subséquent est requis pour effectuer une nouvelle évaluation physique ou mentale.

Certains types d'examens sont réputés répondre aux exigences :

- L'examen gynécologique incluant l'examen vaginal et l'examen bimanuel incluant, le cas échéant, les prélèvements requis;
- L'examen ophtalmologique comprenant l'acuité visuelle, l'examen de la cornée et de la chambre antérieure avec la lampe à fente, les champs visuels, l'examen du fond de l'œil et la prise de tension oculaire;
- L'examen du rachis, de l'épaule, de la hanche ou du genou, lorsque celui comprend l'évaluation de la fonction de l'articulation impliquant la palpation, la mobilisation et les manœuvres diagnostiques utiles;
- L'évaluation des fonctions mentales supérieures incluant, lorsqu'indiqué, l'évaluation du risque suicidaire.

Le tarif est modulé selon que le patient est vulnérable ou non, que le médecin atteint ou non le seuil d'inscription de 500 patients ou plus et selon que le patient a moins de 80 ans ou 80 ans ou plus

Codes	Patient inscrit ou non	ÂGE	Patients inscrits
15773	Non vulnérable	80 et -	500 et -
15774	Non vulnérable	80 et -	500 et +
15775	Vulnérable	80 et -	500 et -
15776	Vulnérable	80 et -	500 et +
15777	Non vulnérable	80 et +	500 et -

15778	Non vulnérable	80 et +	500 et +
15779	Vulnérable	80 et +	500 et -
15780	Vulnérable	80 et +	500 et +

Visite d'évaluation mineure

Réalisée à la demande d'un médecin, d'un dentiste, d'un optométriste ou d'une sage-femme pour obtenir l'opinion du médecin en raison de la complexité ou la gravité du cas ou de l'expertise du médecin

Non facturable si demandé par IPS

Évaluation de la visite ponctuelle mineure et, au besoin, la révision du dossier, plan de traitement ou d'investigation, ordonnances, recommandations et échanges courants avec patient et ses proches. Production d'un rapport écrit de l'évaluation, des recommandations et des investigations ou traitements.

15789	Patient inscrit ou non
--------------	------------------------

— **Plan ELITE** : Sélectionner « **Professionnel référent** » dans la case « **Type de référent** ». Inscrire le numéro du professionnel dans la case « **Professionnel référent** ». Pour créer un nouveau référent, veuillez vous référer à l'annexe 3.

— **Plan ELITE-SAISIE** : Vous devez fournir le numéro du professionnel référent sur votre castonguette.

Visite d'évaluation complexe

Réalisée à la demande d'un médecin, d'un dentiste, d'un optométriste ou d'une sage-femme pour obtenir l'opinion du médecin en raison de la complexité ou la gravité du cas

Pas facturable si demandé par IPS

Évaluation physique ou mental de la visite ponctuelle complexe et, au besoin, la révision du dossier, le plan de traitement ou d'investigation, ordonnances, recommandations et échanges courants avec patient et ses proches. Production d'un rapport écrit de l'évaluation, des recommandations et des investigations ou traitements

15790	Patient inscrit ou non
--------------	------------------------

— **Plan ELITE** : Sélectionner « **Professionnel référent** » dans la case « **Type de référent** ». Inscrire le numéro du professionnel dans la case « **Professionnel référent** ». Pour créer un nouveau référent, veuillez vous référer à l'annexe 3.

— **Plan ELITE-SAISIE** : Vous devez fournir le numéro du professionnel référent sur votre castonguette.

L'Intervention clinique (raccourci I)

L'intervention clinique est, en termes de contenu clinique, équivalente à un examen ou à une consultation, mais

elle est d'une durée plus longue pour des raisons diverses que ce soit, par exemple, à cause de l'importance du conseil, du soutien ou de l'information à transmettre au patient et, selon le cas, à ses proches, ou encore parce que la communication avec le patient doit se faire par l'intermédiaire d'un interprète ou d'un accompagnateur.

Pour donner droit à la rémunération prévue pour l'intervention clinique, la séance doit être d'au moins **25 minutes**. À compter de 30 minutes, une ou des **périodes supplémentaires de 15 minutes** peuvent être facturées. Pour avoir droit à la dernière période de 15 minutes, vous devez avoir rendu des services pendant un **minimum**

de 8 minutes. Le temps consacré à l'ensemble de cette intervention doit se faire de façon **ininterrompue**. **Maximum 180 minutes dans la journée tous lieux confondus.**

— **Plan ELITE** : vous avez 2 façons d'indiquer l'information pour la saisie :

- Raccourci I + durée et inscrire l'heure de début exacte. **Ex. : I38 à 14h**
- Heure de début- heure de fin de l'intervention. **Ex. : I1400-1438**

Selon le contexte, certaines interventions cliniques ne sont pas comptabilisées pour les fins du plafond (maximum de 180 minutes), une précision doit être inscrite sur la demande de paiement (**Alias #**) :

- Intervention clinique effectuée pour un problème de santé mentale; (**Alias #ICSM**)
- Intervention clinique effectuée pour un problème de toxicomanie; (**Alias #ICTOX**)
- Intervention clinique effectuée pour un problème de santé figurant à l'EP – Médecine de famille, prise en charge, suivi de la clientèle (par. 5.01); (**Alias #ICEP**)
- Intervention clinique effectuée auprès d'une clientèle pédiatrique d'un centre de pédiatrie sociale ou d'un programme Petite enfance d'un CLSC (**Alias #ICP**)

Chevauchement : Lorsque la dernière période supplémentaire **est d'au moins 8 minutes**, une intervention clinique subséquente effectuée auprès d'un autre patient ne peut être facturée avant que le délai de 15 minutes de la dernière période supplémentaire de la précédente intervention ne soit écoulé. La dernière période supplémentaire doit avoir une durée minimale de 8 minutes pour qu'elle soit rémunérée selon le tarif prévu pour une période complète de 15 minutes.

La limitation du non-chevauchement concerne seulement l'intervention clinique lorsqu'elle est successive. Vous pourriez facturer une visite (VS) pour un patient suivant alors que l'intervention clinique est terminée, mais toujours rémunérée. Par exemple, une intervention clinique de 55 minutes est facturée de 11h00 à 11h55, mais rémunérée jusqu'à 12h00 (60 minutes) vous permettrait de voir un patient débutant à 11h57 pour lequel vous factureriez une visite de suivi (VS). Cet acte inclut, à la même séance et pour le même patient, l'examen, la consultation, les activités cliniques préventives, la psychothérapie ou tout autre acte sauf le plateau de chirurgie.

Si vous effectuez la **supervision** d'un ou plusieurs résidents, il vous sera possible de facturer un chevauchement partiel d'intervention clinique lorsque la présence du médecin superviseur se limite à certaines phases de la prestation du service rendu avec le concours d'un résident en plus de se prévaloir de l'intervention clinique pour un service qu'il a lui-même rendu à un autre patient.

— **Plan ELITE** : pour l'intervention avec le concours du résident, vous devez indiquer dans la case « résident qui a vu le patient » le numéro du résident. (La lettre « R » est remplacée par le chiffre 5. (5XXXXX))

Les actes de CNESST ou autres formulaires facturables à la RAMQ (doivent être exclus du temps comptabilisé comme intervention clinique individuelle).

L'heure exacte du début de l'intervention clinique est OBLIGATOIRE.

8858	Individuelle – 30 premières minutes (minimum 25 minutes)
8860	Période de 15 minutes supplémentaires
8861	Temps de déplacement au domicile par période 15 minutes – requiert l'heure de début et de fin entre chaque domicile

CODES D'ACTES QUE VOUS POUVEZ FACTURER AVEC UNE INTERVENTION CLINIQUE INDIVIDUELLE

Codes	Description
15169	Forfait clientèle vulnérable

(au bureau)	
15170 (à domicile)	

Codes	Description
15145	Un supplément s'ajoute lorsque l'intervention clinique est faite dans le cadre d'un suivi de grossesse.
15159	Supplément à l'examen de prise en charge de grossesse est accordé lorsque cet examen est fait au cours du premier trimestre (13 premières semaines de grossesse) de la grossesse de la patiente. Requiert la date des dernières menstruations
15189	Supplément pour la prise en charge temporaire et le suivi de grossesse
19074	Supplément pour la prise en charge temporaire et le suivi de grossesse en GMF
8875	Forfait GMF
19957	Supplément pour la prise en charge d'un patient sans médecin de famille non vulnérable
19958, 19959, 19960, 19965	Suppléments pour la prise en charge d'un patient sans médecin de famille vulnérable
13, 14, 15234	Constat de décès
15265	Rédaction du bulletin de décès (SP-3)
FORMULAIRES	CNESST

Le médecin qui consacre plus de vingt-cinq (25) minutes à la rencontre avec son patient peut être rémunéré, à son choix, à l'acte au tarif de la visite ou de la consultation, ou selon les présentes dispositions relatives à l'intervention clinique.

Si le médecin qui exerce dans un CLSC doit se **déplacer à domicile**, un supplément (**code d'acte 08861**) de **27,40 \$ par période de 15 minutes** est payable pour son déplacement au-delà des **10 premiers kilomètres** des limites de la ville ou du village où il exerce. **Un maximum de six périodes est permis pour l'aller-retour. Donc, 45 minutes pour l'aller et 45 minutes pour le retour.**

8861	Supplément pour se déplacer à domicile par période de 15 minutes
------	--

PROGRAMME DE SANTÉ MENTALE

GÉNÉRALITÉ DE RÉMUNÉRATION : Le médecin est rémunéré selon le mode à tarif horaire (ou à honoraires fixes) auquel s'ajoute des suppléments d'honoraires de 40,28 %, de 19,40 % ou de 100 % selon la nature des services rendus.

DÉSIGNATION: le médecin doit être désigné par l'établissement et détenir une nomination spécifique à tarif horaire ou à honoraires fixes dans le cadre du programme de santé mentale dans une installation d'un CLSC exploitée par un CISSS ou un CIUSSS. Toutefois, le médecin n'a pas l'obligation de détenir des privilèges en psychiatrie.

CNESST : Lorsque le médecin complète les formulaires de CNESST, il ne peut comptabiliser le temps nécessaire pour remplir les formulaires prescrits à ces lois pour facturer son tarif horaire ou ses honoraires fixes.

GARDE EN DISPONIBILITÉ : Le médecin qui rend des services lorsqu'il est en disponibilité, est rémunéré selon l'entente générale, soit à l'acte en indiquant l'élément de contexte « garde en disponibilité » #DISPO.

INSCRIPTION DE CLIENTÈLE :

Vous pouvez inscrire de la clientèle à votre nom et ainsi recevoir le forfait annuel d'inscription et de vulnérabilité. Quant au supplément de vulnérabilité, il se facture avec l'intervention clinique seulement.

Les codes d'activité pour la facturation du tarif horaire sont les suivants :

- **276015** Examens relatifs à l'hépatite C
- **276030** Services cliniques *
- **276031** Étude de dossiers
- **276032** Rencontres multidisciplinaires
- **276037** Planification – Programmation – Évaluation
- **276043** Tâches médico-administratives et hospitalières (**secteur de dispensation : 0**)
- **276055** Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- **276063** Garde sur place
- **276071** Garde sur place à même les 35 premières heures d'activités professionnelles hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l'annexe XIV, aucune limitation d'heures (TH seulement).
- **276098** Services de santé durant le délai de carence

La spécificité de ce programme est de permettre aux médecins qui en font partie de facturer en plus de leur tarif horaire et des suppléments habituels, les actes suivants :

	CODES	% DU SUPPLÉMENT D'HONORAIRES	FACTURABLE DURANT LA GARDE EN DISPONIBILITÉ	PARTICULARITÉS
Visite de prise en charge psychiatrique	15918	40,28	Oui	⌚ Réalisée lors de la visite initiale d'un patient ou lors de son inscription auprès d'un médecin ⌚ Peut être faite à la demande d'un autre professionnel de la santé ou du médecin traitant qui souhaite un suivi conjoint ⌚ Évaluation d'un nouveau patient inscrit ou non auprès d'un autre médecin ou d'un nouveau patient que le médecin accepte d'inscrire ⌚ Le médecin assure un suivi psychiatrique seul s'il inscrit le patient ou conjointement avec le médecin traitant La visite comprend : ⌚ l'examen psychiatrique du patient; ⌚ le plan de traitement ou d'investigation; ⌚ les ordonnances; ⌚ l'évaluation physique, le cas échéant; ⌚ les recommandations; ⌚ les échanges courants avec le personnel, le patient ou ses proches; ⌚ le rapport au médecin traitant ou au professionnel qui a fait la demande, s'il y a lieu. Le médecin consigne ses notes au dossier. Cette visite peut être rémunérée qu'une seule fois par un médecin à l'égard d'un même patient.
Visite de suivi psychiatrique	15919	40,28	Oui	⌚ Implique la présence du patient ⌚ Gestion des problèmes courants de santé mentale du patient, que le médecin assume ou non la responsabilité principale du patient et que le patient soit inscrit ou non à son nom ⌚ Ne peut être facturé le même jour que l'examen psychiatrique, l'intervention clinique ou toute autre visite de nature psychiatrique du patient ⌚ Peut être facturé le même jour que les échanges interdisciplinaires avec les intervenants en santé mentale ou les proches du patient La visite inclut, au besoin : ⌚ la consultation du dossier; ⌚ la prescription des investigations ou des traitements requis; ⌚ les échanges avec le personnel. Le médecin consigne ses notes au dossier.

	CODES	% DU SUPPLÉMENT D'HONORAIRE	FACTURABLE DURANT LA GARDE EN DISPONIBILITÉ	PARTICULARITÉS
Visite de suivi psychiatrique exigeant un examen	15920	40,28	Oui	⌚ Examen du patient, que le médecin assume ou non la responsabilité principale du patient, qu'il assure le suivi du patient inscrit ou non, ou qu'il intervienne de façon ponctuelle Le médecin peut facturer cette visite pour : ⌚ évaluer un problème de santé mentale; ⌚ débiter ou prodiguer un traitement; ⌚ évaluer un traitement en cours; ⌚ suivre l'évolution d'une maladie ou d'une complication. La visite inclut au besoin : ⌚ l'examen physique du patient; ⌚ la révision du dossier; ⌚ l'élaboration d'un plan de traitement ou d'investigation; ⌚ les ordonnances; ⌚ les échanges avec le patient, ses proches ou le personnel clinique. Le médecin consigne ses notes au dossier.
Visite d'évaluation psychiatrique pour donner une opinion	15921 <i>Requiert un référant</i>	19,40	Oui	⌚ Opinion donnée à la demande du médecin traitant en raison de la complexité ou de la gravité du cas Le médecin doit produire un rapport écrit : ⌚ de son évaluation et de ses recommandations; ⌚ du traitement qu'il recommande ou débute, le cas échéant. En plus de l'examen psychiatrique, la visite inclut au besoin : ⌚ l'examen physique du patient; ⌚ la révision du dossier; ⌚ l'élaboration d'un plan de traitement ou d'investigation; ⌚ les ordonnances; ⌚ les recommandations; ⌚ les échanges avec le patient, ses proches ou le personnel clinique. Si le médecin revoit le patient lors d'une visite qui découle de sa visite d'évaluation, il ne peut facturer de nouveau cette visite. Il peut alors facturer la visite de suivi avec le code de facturation 15919.

	CODES	% DU SUPPLÉMENT D'HONORAIRE	FACTURABLE DURANT LA GARDE EN DISPONIBILITÉ	PARTICULARITÉS
Examen d'évaluation médicale d'un patient en perte d'autonomie	9100 ou CTMSP	40,28	Oui	
Supplément pour la communication par l'intermédiaire d'un interprète	15188	40,28	Oui	

— **Plan ELITE** : L'élément de contexte #PSM doit être ajouté à tous les actes et suppléments facturés en plus des heures facturées à TH.

AUTRES PRÉCISIONS

Pour les raccourcis clavier, ainsi que la liste de tous les éléments de contexte détaillés, veuillez vous référer à la liste disponible sur Facturation.net via l'aide en ligne ou au document transmis par votre conseiller en facturation.

SECTEUR POUR LA FACTURATION À L'ACTE

— **Plan Élite**: pour la facturation des suppléments rendus à l'acte, veuillez utiliser le secteur de pratique
« AUCUN SECTEUR »

ÉLÉMENT DE CONTEXTE À L'ACTE

Alias (#alias)	Détails sur l'élément de contexte	Où mettre l'élément de contexte
DISPO	Lorsque des actes sont rendus durant une période de garde en disponibilité	Sur les demandes de patients
SI93	Site anatomique différent	sur le second acte qui concerne un site anatomique différent
SD94	Séance différente	si plusieurs visites, examens ou interventions cliniques sont facturés pour un même patient, la même journée et dans un même lieu, #SD94 doit être appliqué sur toutes les visites, interventions cliniques ou examens subséquents. Sur le ou les actes effectués à une séance différente du premier acte
ADT	Lorsque plus d'un acte diagnostique ou thérapeutique est dispensé au cours de la même séance, le médecin reçoit le plein montant de l'honoraire	Sur le ou les actes diagnostiques ou thérapeutiques facturés en plus d'un

	payable pour l'acte le mieux rémunéré et la moitié pour chaque acte additionnel (50%)	premier acte chirurgical la même séance
CHIR	Lorsque plusieurs chirurgies sont faites au cours de la même séance, le médecin reçoit le plein montant de l'honoraire payable pour l'acte le mieux rémunéré et la moitié pour chaque acte additionnel (50%)	Sur le ou les actes chirurgicaux facturés en plus d'un premier acte chirurgical la même séance
ICEP	Intervention clinique effectuée pour un problème de santé figurant à l'EP - Médecine de famille, prise en charge, suivi de la clientèle (par. 5.01)	L'acte d'intervention clinique
ICP	Intervention clinique effectuée auprès d'une clientèle pédiatrique d'un centre de pédiatrie sociale ou d'un programme Petite enfance d'un CLSC	L'acte d'intervention clinique
ICSM	Intervention clinique effectuée pour un problème de santé mentale	L'acte d'intervention clinique
ICTOX	Intervention clinique effectuée pour un problème de toxicomanie	L'acte d'intervention clinique

PLAGE HORAIRE À L'ACTE

PLAGE	DÉBUT	FIN
NU	00 h	08 h
AM	08 h	12 h
PM	12 h	18 h
SO	18 h	24 h

— **Plan ÉLITE:** à tarif horaire, veuillez sélectionner la plage horaire selon l'heure à laquelle les services ont été rendus

MAJORATION APPLICABLE À L'ACTE

PÉRIODE	HEURE	MAJORATION (%)
Lundi, mardi, mercredi ou jeudi	18 h à 22 h	20,45
Vendredi	18 h à 22 h	36,17
Samedi, dimanche ou journée fériée	8 h à 24 h	
Samedi, dimanche ou journée fériée (sans rendez-vous d'une clinique-réseau)	8 h à 24 h	47,18

Vous devez spécifier sur la demande de paiement les heures de début pour chaque visite afin d'obtenir la majoration applicable.

SYMBOLES UTILISÉS POUR LES UTILISATEURS DU PLAN ELITE

SYMBOLE	DESCRIPTION	EXEMPLE
#	Élément de contexte	EX : VS#SD94
:	UNITÉ	EX : 1323:3

Un acte pratiqué à un site anatomique différent, par exemple sur les deux pieds, peut être identifié de cette façon : soit avec l'élément de contexte SI93. Par exemple, voici comment devrait être identifié l'acte 2756 (réduction interphalengienne – pied) pour plus d'un orteil, sur les deux pieds : **2756:3,2756:2#SI93**.

Pour une séance différente, lorsque vous voyez le patient à des heures différentes, veuillez ajouter l'élément de contexte de séance différente **#SD94** suivant l'acte facturé. **Exemple : 431,431#SD94**

DIAGNOSTICS

La RAMQ indique qu'elle compte sur votre collaboration pour indiquer un diagnostic, mais qu'il ne s'agit pas d'une obligation. Il suffit d'utiliser une vingtaine de codes de diagnostics généraux, vous n'avez pas être très spécifique.

GARDE EN DISPONIBILITÉ – EP 38

La garde en disponibilité effectuée par un médecin se prévalant de la présente entente particulière est rémunérée selon une formule de rémunération à l'acte, à raison d'un ou plusieurs forfaits quotidiens réguliers additionnés de la rémunération à l'acte prévue à l'Entente.

L'établissement doit transmettre à la RAMQ le formulaire 3547 - Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte

La garde en disponibilité **doit être assurée durant toute la semaine**, mais elle n'est rémunérée en vertu de la présente entente :

- Qu'à compter du samedi à 0h00 au dimanche suivant à 24h00 et les jours fériés de 0h00 à 24h00;
- Qu'à compter de 20h00 à 24h00 et de 0h00 à 8h00 sur semaine, soit du lundi au vendredi inclusivement.

Elle est rémunérée pour une période de 8h, mais est divisible en heures.

Inscrire l'heure de début et de fin de garde

CODES DE GARDE

Codes de garde	Forfait réduit 32 \$	Forfait régulier 64 \$	Forfait majoré 96 \$
En semaine (autre qu'un jour férié)	19059	19060	19061
Plan ELITE : Type FORFAIT Formule pour la facturation : code:nombre de minutes:heure de début-heure de fin: Séparer par plage horaire : soir (20h-24h) et nuit (0h-8h) Ex. de garde : 19060 :240 :2000-2400 / 19061:60:2000-2100			
Fin de semaine et jours fériés	9856	9857	9727
Plan ELITE : Type FORFAIT Formule pour la facturation : code:nombre de minutes:heure de début-heure de fin: Si vous assurez la garde toute la journée, faire une seule de facture : ex. 9857:1 440:0000-2359			

Nepas mettre l'heure définie à 24h pour ne pas créer une demande avec le statut «Invalide». Ex. de garde: **9857:480:0000-0800**

GARDE SIMULTANÉE

Lorsque vous assurez la garde en disponibilité dans plusieurs lieux et que la facturation de celle-ci s'effectue dans un seul lieu, vous pourriez avoir droit de facturer de la garde en disponibilité simultanée si votre établissement a droit au double de forfait quotidien (ex. 6 forfaits la fin de semaine et 3 la semaine).

Pour la facturation, vous doublez le nombre de minutes pour chaque plage horaire où la garde en simultanée a été effectuée et vous ajoutez l'élément de contexte **Garde simultanée** (alias #GS).

— **Plan ELITE-SAISIE** : vous devez nous préciser que vous effectuez de la garde simultanée

— **Plan ELITE** : Vous devez doubler le nombre de minutes par plage horaire et vous devez ajouter l'élément de contexte #GS à la formule de facturation. Il est important de ne pas faire plusieurs factures, ou ligne de facture pour la même plage horaire.
Ex. : 9857:480:2000-2400#GS

SERVICES RENDUS DURANT LA GARDE EN DISPONIBILITÉ

Les services rendus durant la garde en disponibilité sont rémunérés à l'acte selon les dispositions prévues par l'Entente.

Ils sont facturables à l'établissement ou l'installation où les services ont été rendus.

— **Plan ELITE** : Ajouter l'élément de contexte **#DISPO** aux services rendus. Ex. : **VS#DISPO**

SUIVI DE GROSSESSE

Cette section s'applique pour les médecins qui suivent des patientes durant leur grossesse

CODES	DESCRIPTION
SUPPLÉMENT DE PRISE EN CHARGE GROSSESSE	
15159	Supplément à l'examen de prise en charge de grossesse est accordé lorsque cet examen est fait au cours du premier trimestre (13 premières semaines de grossesse) de la grossesse de la patiente Se facture lors de la prise en charge de grossesse sur la même demande que l'intervention clinique. La date des dernières menstruations (DDM) est OBLIGATOIRE. Ce supplément peut être facturé même si le médecin ne détient pas de privilèges en obstétrique. Lorsque le médecin ne prévoit pas effectuer lui-même l'accouchement de la patiente enceinte, une entente doit avoir été conclue avec un autre médecin qui exerce en obstétrique afin d'assurer le suivi lorsque requis ainsi que l'accouchement de la patiente. Ce supplément n'est payable qu'une seule fois par patiente. Dans le cas où un médecin recommande une patiente à un second médecin au cours du premier trimestre de sa grossesse pour en assurer le suivi, le supplément est payable au médecin auquel la patiente a été recommandée. Dans le cas où un médecin recommande une patiente à un second médecin, ce dernier doit inscrire le prénom et le nom complet du médecin référent dans la case RÉFÉRENT.
SUPPLÉMENT DE SUIVI DE GROSSESSE	
15145	Un supplément s'ajoute également à l'examen fait dans le cadre d'un suivi de grossesse. Incompatible avec le supplément à l'examen de prise en charge de grossesse. Ce supplément peut être facturé même si le médecin ne détient pas de privilèges en obstétrique. Lorsque le médecin ne prévoit pas effectuer lui-même l'accouchement de la patiente enceinte, une entente doit avoir été conclue avec un autre médecin qui exerce en obstétrique afin d'assurer le suivi lorsque requis ainsi que l'accouchement de la patiente. Incompatible avec le supplément à l'examen de prise en charge de grossesse 15159
SUPPLÉMENT POUR PRISE EN CHARGE TEMPORAIRE	
15189	Supplément pour la prise en charge temporaire et le suivi de grossesse est accordé au médecin qui détient des privilèges en obstétrique et assume temporairement le suivi d'une patiente enceinte et fait des accouchements sans devenir son médecin de famille. Le domicile du patient peut également être reconnu comme lieu de prise en charge et de suivi lorsque le suivi est assuré principalement à domicile. Ce supplément n'est payable qu'une seule fois par grossesse de la patiente et doit être facturé lors de l'examen fait au moment de la prise en charge effective de la grossesse par

15189 (suite)	le second médecin, quel que soit son mode de rémunération (acte, honoraires fixes ou tarif horaire). Inscrire la date des dernières menstruations (DDM) Le médecin de famille auprès duquel la patiente enceinte est inscrite ne peut pas facturer ces suppléments. Aucun formulaire d'inscription ne doit être rempli par le médecin qui prend en charge temporairement la patiente enceinte.
19074	En GMF , le forfait s'applique au médecin qui, dans le cadre de sa pratique en obstétrique, assume temporairement le suivi d'une patiente inscrite auprès d'un autre médecin du même GMF. Le médecin doit détenir des privilèges en obstétriques . Payable une fois par grossesse lors de l'examen de PEC de grossesse. Inscrire la date des dernières menstruations (DDM)

INSCRIPTION DE LA CLIENTÈLE

FORFAIT INSCRIPTION GÉNÉRALE

Le forfait d'inscription générale est versé automatiquement par la Régie au médecin de famille pour tous ses patients actifs au 1^{er} janvier de l'année de versement. Le patient est considéré actif lorsqu'il a rencontré **son médecin de famille** au cours des trente-six (36) mois précédents. Le forfait est versé dans sa totalité même si l'inscription ou la modification a eu lieu en cours d'année d'application.

Si un patient fait l'objet d'inscription auprès de deux médecins de famille, le calcul se fait alors sur la base des mois entiers et le mois de la deuxième inscription est comptabilisé en faveur du premier médecin.

Ce versement forfaitaire sera effectué au mois de mai de chaque année. Montant maximum de 8,85 \$, calcul au prorata si plus d'un médecin.

PATIENT SANS MÉDECIN DE FAMILLE

Le médecin qui accepte d'inscrire, de prendre en charge et de suivre un patient vulnérable ou non vulnérable et sans médecin de famille, sur référence ou non du guichet du GAMF, a droit à un montant supplémentaire qui sera versé en **un seul versement** à l'inscription du patient à l'occasion d'un examen ou d'une intervention clinique.

19957	Lorsque le patient est sans médecin de famille non vulnérable, qu'il soit priorisé ou non et référé ou non par le GAMF
19958	Lorsque le patient est sans médecin de famille vulnérable, non priorisé et non référé par le GAMF
19959	Lorsque le patient est sans médecin de famille vulnérable, priorisé et référé par le GAMF
*19960	Lorsque le patient est sans médecin de famille très vulnérable priorisé et référé par le GAMF et répondant à certaines conditions de vulnérabilité catégorie 1 et 11, 20 et 11 ou 6

19965

Lorsque le patient est vulnérable, attribué ou non par le GAMF (**une fois le maximum de 150 patients atteint, les codes de facturation 19958 et 19959 ne doivent plus être utilisés**).

*Vous aurez à utiliser le code 19960 au lieu de 19959 (priorisé, référé et vulnérable) si vous avez un patient référé par le guichet qui aurait comme problème de santé **(01)** problème de santé mentale **et (11)** troubles dépressifs majeurs récidivants **(les deux codes) (20)** problème de santé (DSM-IV) et **(11)** troubles dépressifs majeurs récidivants **(les deux codes) ou (06)** toxicomanie ou alcoolisme.

Afin de se prévaloir des suppléments prévus aux paragraphes 4.12 A), 4.12 C) et 13.01 de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le médecin peut inscrire un maximum de 150 patients, vulnérables ou non, référés par le GAMF ou par transfert en bloc par année civile.

Lorsque la limite de 150 patients attribués est atteinte, le médecin peut se prévaloir uniquement des suppléments **19957, 19965 et 19960** pour les patients subséquents. Il ne peut plus facturer les suppléments **19959 et 19958**. Ainsi, pour le patient vulnérable, qu'il soit attribué ou non par le GAMF ou par transfert en bloc, le médecin doit facturer le supplément prévu **19965**.

Le maximum de patients qu'un médecin coordonnateur pourra désormais référer à un médecin sur la base d'une année civile est de 150. Cette limite ne s'applique pas à un médecin au cours des quatre années de pratique qui suivent l'obtention de son permis du CMQ.

Lors des quatre premières années suivant l'obtention de son permis de pratique, le médecin n'a pas à respecter la limite annuelle de 150 patients. La première année de pratique se calcule à partir du 1er janvier suivant l'obtention du permis de pratique du médecin.

Le supplément doit être facturé sur la même demande de paiement et à la même date que l'examen ou l'intervention clinique.

Vous avez **60 jours** pour inscrire un patient provenant du GAMF à l'exception des médecins participant à la lettre d'Entente 321 (bloc de patient).

 **Plan ELITE** : veuillez utiliser le NAM patient et le supplément doit être facturé sur la même demande de paiement et à la même date que l'examen de prise en charge ou l'intervention clinique.

SUPPLÉMENT A L'EXAMEN PÉRIODIQUE D'UN ENFANT AGE DE 0 A 5 ANS

Le médecin qui fait un examen périodique auprès d'un enfant âgé de 0 à 5 ans qu'il a inscrit selon les dispositions de la présente entente reçoit un supplément à chaque examen périodique.

Permis avec l'intervention clinique seulement.

Le médecin doit répondre aux exigences de l'ABCdaire du suivi de l'enfant âgé de 0 à 5 ans;

Le nombre d'examen périodiques et d'interventions cliniques individuelles admissibles au supplément prévu au présent paragraphe se répartit comme suit :

- entre 0 et 21 mois: **huit (8) visites**
- entre 22 et 63 mois: **une (1) visite par année civile.**

8877

Supplément à l'examen périodique d'un enfant âgé de 0 à 63 mois

LA CLIENTÈLE VULNÉRABLE

L'inscription de patient comme clientèle vulnérable permet de facturer **un forfait de responsabilité à chaque examen, intervention clinique ou psychothérapie** d'un patient et de recevoir un forfait annuel pour la prise en charge du patient inscrit. Les patients doivent présenter une ou plusieurs conditions de vulnérabilité numérotées de 01 à 20 (maximum trois codes de vulnérabilité que vous pouvez inscrire à la RAMQ).

L'identification des patients doit être transmise à la RAMQ conformément aux modalités prévues selon : remplir et conserver une copie du formulaire no 4096 ou faire l'inscription du patient à la RAMQ par le biais des Services en ligne.

15169	Supplément de vulnérabilité
15170	Supplément de vulnérabilité à domicile

TABLEAU DES CONDITIONS DE VULNÉRABILITÉ

CODE DE CATÉGORIE DE PROBLÈME EN SANTÉ	CATÉGORIES DE PROBLÈMES DE SANTÉ OU D'ÂGE CORRESPONDANT À LA CONDITION DE VULNÉRABILITÉ	LETTRE ASSOCIÉE
01	Problèmes de santé mentale chroniques et récidivants (DSM-V) : troubles d'anxiété généralisée, troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie).	A
02	Maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), asthme de modéré à sévère (patient présentant un vers inférieur à 70 % de la valeur prédite), pneumopathies professionnelles.	B
03	Maladie cardiaque artério-sclérotique (MCAS), insuffisance cardiaque, hypertension sévère (grade 3).	C
04	Cancer associé à un traitement passé, présent ou projeté en chimiothérapie systémique ou radiothérapie ou en phase palliative.	D
05	Diabète avec hémoglobine A1C à 6,5 ou plus au moment du diagnostic excluant le diabète de grossesse.	E
06	Toxicomanie ou alcoolisme en cours de sevrage ou ayant donné lieu à une cure de désintoxication de drogues dures ou d'alcool au cours des cinq dernières années, toxicomanie sous traitement à la méthadone ou de buprénorphine.	F
07	VIH/SIDA, hépatite C.	G
08	Maladies dégénératives du système nerveux, démence avec MMSE de 26 et moins, blessés médullaires avec séquelles permanentes entraînant une invalidité et des traumatismes crâniens avec séquelles permanentes entraînant une invalidité.	H
09	Maladies inflammatoires chroniques : polyarthrite, rhumatoïde, psoriasis avec atteinte autre que cutanée, lupus, sclérodermie et autres collagénoses, colite ulcéreuse, maladie de Crohn.	I
10	Troubles dépressifs majeurs aigus, premier épisode ou troubles anxieux aigus, premier épisode. Renouvelable tous les 24 mois.	A

11	Troubles dépressifs majeurs récidivants.	A
12	Insuffisance rénale chronique avec une clairance de la créatine, inférieure à 30 ml par minute, insuffisance hépatique.	J
13	Maladies thrombogènes nécessitant une anticoagulation à vie, fibrillation auriculaire avec CHADS à 2 et plus.	K
14	Fibrillation auriculaire nécessitant une anticoagulothérapie à vie et suivi par RIN. Date de fin : 30 juin 2019	L
15	Trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité pour les patients âgés de moins de 18 ans.	M
16	Déficiência intellectuelle pour les patients présentant des troubles importants d'expression et de compréhension.	N
17	Déficiência auditive lorsque la communication avec le patient se fait de façon gestuelle ou par écrit et déficiencia visuelle nécessitant la présence d'un accompagnateur lors de la rencontre du patient avec le médecin.	O
18	Douleur chronique qui persiste depuis plus de six (6) mois liée à une condition chronique et provoquant une incapacité fonctionnelle ou nécessitant la prise continue d'une médication sur ordonnance lui permettant d'être fonctionnel.	P
19	Accident vasculaire cérébral entraînant des troubles graves de mobilité, de comportement, d'expression ou de compréhension.	Q
20	Problèmes de santé (DSM-IV) : troubles psychotiques, troubles bipolaires, troubles envahissants du développement (troubles du spectre de l'autisme, Asperger), trouble de panique.	A

CATÉGORIES DE PROBLÈMES DE SANTÉ RETENUES

A) 1. Problèmes de santé mentale chroniques et récidivants (DSM-V) : troubles d'anxiété généralisée, troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie);

2. Problèmes de santé (DSM-IV) : troubles psychotiques, troubles bipolaires, troubles envahissants du développement (troubles du spectre de l'autisme, Asperger);

3. Troubles dépressifs majeurs aigus, premier épisode ou troubles anxieux aigus, premier épisode;

Note : À compter du 1^{er} juillet 2017, en regard d'un patient l'inscription à cette catégorie prend fin le 30 juin 2019 (pour les inscriptions existantes) ou vingt- quatre (24) mois après l'inscription ou la confirmation (pour les inscriptions après le 30 juin 2017), à moins que le médecin confirme, durant les trois (3) mois avant la fin du délai, que le patient répond toujours aux exigences de cette catégorie.

4. Troubles dépressifs majeurs récidivants;

B) Maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), asthme de modéré à sévère (patient ayant présenté un vems inférieur à 70 % de la valeur prédite), pneumopathies professionnelles;

C) Maladie cardiaque artério-sclérotique (MCAS), insuffisance cardiaque, hypertension sévère (grade 3);

D) Cancer associé à un traitement passé, présent ou projeté en chimiothérapie systémique ou radiothérapie ou en phase palliative;

E) Diabète avec hémoglobine A1C à 6,5 ou plus au moment du diagnostic excluant le diabète de grossesse.

Note : Lors d'une inscription subséquente, lorsque le taux d'hémoglobine A1C au moment de poser le diagnostic ne peut être documenté, le patient qui est sous traitement actif pour diabète, excluant le diabète de grossesse, est présumé répondre à ce critère;

F) Toxicomanie ou alcoolisme en cours de sevrage ou ayant donné lieu à une cure de désintoxication de drogues dures ou d'alcool au cours des cinq (5) dernières années, toxicomanie sous traitement de méthadone ou de buprénorphine;
 G) VIH/SIDA, hépatite C;
 H) Maladies dégénératives du système nerveux, démence avec MMSE de 26 et moins, blessés médullaires avec séquelles permanentes entraînant une invalidité et des traumatismes crâniens avec séquelles permanentes entraînant une invalidité;
 I) Maladies inflammatoires chroniques : polyarthrite rhumatoïde, psoriasis avec atteinte autre que cutanée, lupus, sclérodermie et autres collagénoses, colite ulcéreuse, maladie de Crohn;
 J) Insuffisance rénale chronique avec une clairance de la créatine, inférieure à 30 ml par minute, insuffisance hépatique;
 K) Maladies thrombogènes nécessitant une anticoagulation à vie, fibrillation auriculaire avec CHADS à 2 et plus;
 L) Fibrillation auriculaire nécessitant une anticoagulothérapie à vie et un suivi par RIN;
 M) Troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité pour les patients âgés de moins de 18 ans;
 N) Déficience intellectuelle pour les patients présentant des troubles importants d'expression et de compréhension;
 O) Déficience auditive lorsque la communication avec le patient se fait de façon gestuelle ou par écrit et déficience visuelle nécessitant la présence d'un accompagnateur lors de la rencontre du patient avec le médecin;
 P) Douleur chronique qui persiste depuis plus de six (6) mois liée à une condition chronique et provoquant une incapacité fonctionnelle ou nécessitant la prise continue d'une médication sur ordonnance lui permettant d'être fonctionnel ;
 Q) Accident vasculaire cérébral entraînant des troubles graves de mobilité, de comportement, d'expression ou de compréhension

FORFAIT ANNUEL DE PRISE EN CHARGE POUR UN PATIENT VULNÉRABLE

GROUPE DE VULNÉRABILITÉ		BUREAU/ DOMICILE
GROUPE I	le patient est identifié à une seule catégorie de problèmes de santé	46,55\$
GROUPE II	le patient est identifié à deux catégories de problèmes de santé autres que la catégorie A (problèmes de santé mentale) ou la catégorie N (déficience intellectuelle)	69,85\$
GROUPE III	le patient est identifié à trois catégories de problèmes de santé autres que la catégorie A (problèmes de santé mentale) ou la catégorie N (déficience intellectuelle)	93,10\$
GROUPE IV	le patient est identifié à deux catégories ou plus de problèmes de santé dont une de ces catégories est la catégorie A (problèmes de santé mentale) ou la catégorie N (déficience intellectuelle)	93,10\$

- **Forfait annuel de prise en charge** : l'entente prévoit le versement d'un forfait annuel de prise en charge des patients vulnérables inscrits, selon le groupe.
- **Payé 4 fois par année** : le montant est versé sur une base trimestrielle, le premier trimestre débutant le 1^{er} janvier de chaque année.
- **Date de début = première visite du patient** : le forfait est payé à partir de la date de l'inscription du patient et le montant se calcule proportionnellement au nombre de mois de l'année d'application qui reste à écouler.

- **Identification de vulnérabilité** : en tout temps, une catégorie de problème de santé peut être identifiée pour un patient en avisant la Régie au plus tard 90 jours suivant l'examen au cours duquel le problème est identifié ou modifié. S'il y a lieu, le niveau du forfait est rajusté le mois suivant la modification apportée par le médecin.
- **Patient actif au 1^{er} janvier** : le forfait annuel est payable pour chaque patient considéré vulnérable actif au 1^{er} janvier de l'année du versement du forfait annuel. Est considéré comme vulnérable actif, le patient qui a rencontré son médecin de famille auprès duquel il est inscrit au cours des 12 mois précédents. Si cette condition n'est pas remplie, le forfait sera payé à partir du **prochain examen**, intervention clinique, psychothérapie ainsi que le forfait de responsabilité facturé pour ce patient, proportionnellement au nombre de mois de l'année d'application qui reste à écouler, incluant le mois de l'examen, de l'intervention clinique, de la psychothérapie ainsi que le forfait de responsabilité.
- **Changement de médecin** : lorsqu'un patient déjà inscrit s'inscrit auprès d'un autre médecin, le forfait annuel payé à chacun des médecins est proportionnel au nombre de mois couverts pour chacune des inscriptions. Le calcul se fait sur la base de mois entiers, le mois de la seconde inscription étant comptabilisé en faveur du premier médecin.

LA GRANDE INSCRIPTION – LETTRE D'ENTENTE 321

Modalité particulière concernant la prise en charge en lot de patients attribués en lot par le guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF). Veuillez consulter les infolettres en cliquant sur les liens suivants : [Infolettre 303](#) et [Infolettre 100](#)

RÉTABLISSEMENT D'UNE INSCRIPTION

Dans le cas où un médecin est d'avis que l'inscription auprès d'un autre médecin d'un de ses patients inscrits ne reflète pas une prise en charge effective par cet autre médecin, il peut communiquer avec ce patient et lui demander, au moyen du formulaire apparaissant à l'annexe II de la présente entente, de rétablir sa première inscription. Pour que la Régie puisse procéder au rétablissement de l'inscription, ce formulaire doit être acheminé à la Régie **au plus tard dans les six (6) mois suivants la date du rapport transmis par la Régie** pour informer le médecin de la fin de l'inscription de son patient.

Le second médecin ne peut plus contester le rétablissement de l'inscription d'un patient auprès de son premier médecin de famille.

AVIS : Voir le formulaire [Rétablissement d'une inscription auprès d'un médecin de famille](#) (4055).

CONSERVATION DU FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUPRÈS D'UN MÉDECIN DE FAMILLE

La Régie peut demander au médecin de fournir une copie du formulaire d'inscription signé par le patient et lui-même. Le formulaire doit être conservé par le médecin dans le dossier médical du patient.

RETRAITE D'UN MÉDECIN DE FAMILLE

Le médecin de famille qui prend **sa retraite ou diminue sa pratique** en vue de sa retraite **doit informer la Régie** afin qu'elle puisse mettre fin aux inscriptions ou à une partie des inscriptions des patients qu'il ne suivra plus.

Le médecin qui omet d'informer la Régie demeure assujéti aux obligations de prise en charge et de suivi de sa clientèle. **De ce fait, ces patients ne peuvent pas faire l'objet de référence par le guichet d'accès du CSSS en tant que patients sans médecin de famille.**

Sur demande du médecin de famille lui-même auprès de la RAMQ et/ou de son coordonnateur de guichet, sa clientèle devient admissible aux fins du versement du supplément prévu(19957 à 19960 et 19965) dans les cas suivants :

- i) le médecin de famille prend totalement sa retraite à une date connue, celle-ci au plus tard 24 mois suivants sa demande;
- ii) le médecin de famille est en invalidité partielle pour une période suffisamment importante;
- iii) le médecin de famille réoriente graduellement ou partiellement sa pratique vers une pratique autre qu'en première ligne.

Tant qu'il n'est pas inscrit auprès d'un autre médecin de famille, le patient demeure inscrit auprès de son médecin de famille.

ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ GMF (EP 33)

Si votre CLSC est désigné GMF, vous avez le droit de facturer les suppléments et forfaits spécifiques suivants :

FORFAIT DE PRISE EN CHARGE ET DE SUIVI (RACCOURCI GMF)

Le forfait de prise en charge et de suivi du patient inscrit en GMF est facturé une fois par année civile (1^{er} janvier au 31 décembre) par GMF et par patient, lors de la première visite annuelle du patient au GMF. Le forfait s'ajoute à la rémunération du médecin pour chacun de ses patients inscrits.

8875	Forfaitdepriseenchargetdesuivi
-------------	--------------------------------

— **Plan ELITE** : pour les médecins qui utilisent la castonguette électronique intégrée avec Kinlogix et Medesync, l'ajout se fait automatiquement selon les règles établies pour le forfait GMF (8875).

RÉMUNÉRATION DU MÉDECIN RESPONSABLE EN GMF

Les fonctions du médecin responsable sont rémunérées selon un montant forfaitaire versé sur une base hebdomadaire.

19017	Rémunération du médecin responsable en GMF <i>Se facture une fois par semaine, le dimanche</i>
--------------	---

— **Plan ELITE** : veuillez utiliser le type **FORFAIT**.

TARIF HORAIRE

Dans un GMF, les activités cliniques du médecin sont rémunérées selon les modes de rémunération prévus à l'Entente.

Par le biais d'une banque d'heures, est également rémunéré, selon le mode du tarif horaire, le temps que le médecin consacre aux activités professionnelles requises par le fonctionnement en GMF. Ces activités

comprennent notamment les activités de coordination et de suivi en GMF, les activités interdisciplinaires, les activités de concertation avec les autres intervenants du milieu et, enfin, les activités médico-administratives et de formation reliées au fonctionnement en GMF.

Au cours d'une semaine, le médecin qui effectue des activités de fonctionnement peut **cumuler les périodes effectuées**, aux fins de compléter la première heure minimalement requise pour facturer en TH. Pour l'excédent de la première heure journalière, il peut facturer des fractions d'heures.

Lors d'un **congé** ou d'une **absence**, le médecin **ne peut facturer** les heures qui lui sont allouées en activités de fonctionnement. (Ex. congé de maternité, maladie...)

La banque d'heures du GMF est déterminée sur la base de trois heures semaine par médecin équivalent temps plein. Cependant, il est de la responsabilité du médecin responsable de répartir les heures allouées entre les médecins selon des critères qu'il a établis.

72101	Activités de fonctionnement en GMF
72103	Services cliniques en GMF

Taux horaire : **99,48 \$**

Le formulaire doit être signé par vous et le signataire de votre établissement et conservé pour une période de 5 ans. Le nom et prénom de chaque personne doit être indiqué en lettres moulées en plus de la signature pour éviter un refus lors d'une vérification de conformité.

 **Plan ELITE** : veuillez-vous référer à l'ANNEXE 5 pour suivre la procédure de facturation

INSCRIPTION EN GMF

Pour avoir droit au forfait d'inscription générale de la clientèle, l'inscription d'un patient se fait à l'occasion d'un examen, intervention clinique ou une psychothérapie à l'aide du formulaire *Inscription auprès d'un médecin de famille*. Lors de l'inscription, le médecin indique la date de début de l'inscription soit la date de la visite, le lieu où le suivi sera effectué, le code de vulnérabilité, s'il y a lieu, et toutes les données requises. **Il doit conserver au dossier l'original du formulaire signé par son patient et lui en remettre une copie. Nous vous rappelons que vous ne devez pas transmettre le formulaire à la Régie.**

L'inscription doit être reçue à la Régie dans les 90 jours suivant la visite donnant droit à l'inscription à défaut de quoi elle sera refusée.

PRATIQUE CLINIQUES RÉSEAUX GMF-R

(EP 54)

Si vous exercez au sein d'une clinique désignée GMF-R, voici l'information relative à la facturation qui s'ajoute à celle déjà prévue.

TARIF HORAIRE	Bureau : 269111 SRV : 269110 Pour les codes de dispensation à utiliser, veuillez vous référer à la section TARIF HORAIRE au début du guide.
ÉLÉMENT DE CONTEXTE À INDIQUER	Sans rendez-vous – GMF désigné réseau (GMF-R) ou alias #SRVGR pour toute la rémunération à l'acte
SUPPLÉMENT DE GARDE	Lundi au vendredi (sauf jour férié) de 18h à 22h : 19893 Samedi, le dimanche ou un jour férié, de 8 h à 22 h : 19894 Facturable en plus de la rémunération prévue pour les services rendus durant la garde en horaire défavorable. Plan ELITE : Veuillez inscrire l'heure de début et de fin de la garde.
ACTIVITÉS MÉDICO-ADMINISTRATIVES	Pour l'organisation des services de première ligne, la coordination avec l'établissement et les autres intervenants du réseau local de santé et de services sociaux (RLS), la confection des horaires de garde et le recrutement. 3 forfaits (19895) sont alloués par semaine (67.65\$/forfait) dont 2 des 3 forfaits doivent être facturés par le médecin responsable du GMF-R. Pour le forfait résiduel, le médecin doit appliquer l'élément de contexte « alias #FR – forfait résiduel pour les activités médico-administratives en GMR-R » Lorsque le médecin effectue des activités médico-administratives en GMF-R, il ne doit facturer aucun service au cours de cette période . De plus, le temps consacré aux activités médico-administratives doit être déduit du forfait horaire (mode de rémunération mixte) ou des heures rémunérées à tarif horaire ou à honoraires fixes. Plan ELITE : Veuillez inscrire l'heure de début et de fin de l'activité. EX :19895:3:0800-0900

DÉPLACEMENT D'URGENCE DE NUIT

De 0 h à 7 h, un médecin qui, **à la suite d'un appel d'urgence**, doit se rendre auprès d'un patient, à domicile ou en établissement, est rémunéré :

- soit selon la rémunération à l'acte;
- soit selon un tarif global pour l'ensemble des soins dispensés à ce patient.

Les soins dispensés à tout autre patient lors du même déplacement doivent être facturés au tarif d'urgence de dispensation sans déplacement.

9099

Déplacement d'urgence de nuit 0h à 7h

— **Plan ELITE** : veuillez utiliser le NAM patient et ajouter l'élément de contexte #DISPO.

MÉDECIN ENSEIGNANT

RÉSIDENT / EXTERNE

— **Plan ELITE** : vous retrouverez à l'annexe 3 les instructions pour facturation.net

En sus de toute autre rémunération prévue est applicable au médecin qui, selon l'assignation du responsable de stages, assume la prise en charge et la responsabilité de l'externe et/ou du résident **au cours d'une plage horaire**. Cette prise en charge et cette responsabilité impliquent principalement des activités de supervision clinique.

Les activités visées par les présentes sont rémunérées sous forme d'un demi-per diem par plage horaire d'activités. Chaque demi-per diem doit viser des activités dont la durée totale minimale est de 3,5 heures la même journée. Lorsque plus d'un médecin assure la prise en charge et la responsabilité d'un externe ou d'un résident durant la même demi-journée, la durée de l'activité s'évalue en tenant compte du rôle de l'ensemble des médecins, sans dépasser la durée de l'activité de l'externe ou du résident. Les médecins doivent alors convenir duquel parmi eux réclame le demi-per diem pour cette demi-journée pour un externe ou un résident.

Pour réclamer un demi-per diem, le médecin doit effectuer sur place, la supervision d'activités cliniques ou toute autre activité de formation d'un résident ou d'un externe, durant une période minimale de **3,5 heures au cours de la journée**. Au cours d'une demi-journée, un seul médecin peut être rémunéré pour la responsabilité assumée en regard d'un résident ou d'un externe.

CLSC		
19911	Tableau de la liste 1 pour un résident	5XXXXXX
19914	Tableau de la liste 1 pour un externe	XXXXXXXXXX <i>Inscrire E en majuscule</i>
19917	Tableau de la liste 2 pour un résident	5XXXXXX
19920	Tableau de la liste 2 pour un externe	XXXXXXXXXX <i>Inscrire E en majuscule</i>

CLSC GMF-U		
19912	Tableau de la liste 1 pour un résident	5XXXXXX
19915	Tableau de la liste 1 pour un externe	XXXXXXXXXX <i>Inscrire E en majuscule</i>
19918	Tableau de la liste 2 pour un résident	5XXXXXX
19921	Tableau de la liste 2 pour un externe	XXXXXXXXXX <i>Inscrire E en majuscule</i>

Veillez indiquer le numéro du résident ou de l'externe sur votre demande de paiement ainsi que l'heure de début du bloc de supervision de 3.5 heures

Plan Elite : il est important de remplacer la lettre R par 5 à la saisie sinon le système refusera la demande.

Le médecin peut, pendant une demi-journée, assumer la responsabilité de plus d'un résident et/ou externe. Le médecin facture, quotidiennement, par lieu de stages, le nombre de demi-per diem pour le (ou les) résident(s) ou externe(s) supervisé(s).

Si l'enseignement est effectué sur plus d'un lieu de stages, les demi per-diem de supervision doivent être facturées distinctement. **Exemple : 2 résidents supervisés entre 8h et 16h : Heure de début 8h – 1991X:2 + Heure de début 12h – 1991X:2**

INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (IPS) - LETTRE D'ENTENTE 213

Le médecin qui assure la **supervision du stage d'une IPS** pendant sa formation est rémunéré selon les modalités applicables à la prise en charge et à la responsabilité d'un externe de la section I de l'Entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin enseignant.

Avant de facturer le forfait de formation, vous devez identifier si le lieu de formation est lié aux listes 1 ou 2.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

CLSC	
19923	Liste 1
19926	Liste 2

CLSC GMF-U	
19924	Liste 1
19927	Liste 2

Veillez indiquer le numéro de l'IPSPL sur votre demande de paiement.

Le médecin peut, pendant une demi-journée, assumer la responsabilité de plus d'un résident et/ou externe. Le médecin facture, quotidiennement, par lieu de stages, le nombre de demi-per diem pour le (ou les) IPS-SPL(s) supervisé(s).

INTÉGRATION IPS-SPL ET CIPS-SPL – LETTRE D'ENTENTE 389

Les activités du médecin partenaire reliées à la surveillance générale des activités médicales de l'IPS-SPL ou à la supervision de la CIPS-SPL ainsi que de l'observance des normes poursuivant ces finalités reliées à l'exercice des activités médicales de l'IPS-SPL ou de la CIPS-SPL, incluant les discussions de cas, les rencontres d'équipes, la révision de dossiers, sont rémunérées à l'acte selon un ou plusieurs forfaits hebdomadaires.

42272	Pour un médecin rémunéré à tarif horaire
-------	--

— **Plan ELITE** : veuillez utiliser le Type **FORFAIT**

PATIENT INSCRIT PAR UNE IPSPL/CIPSPL

Patient non vulnérable :

L'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) ou la candidate (CIPSPL) peut procéder, avec le consentement du médecin partenaire, à l'inscription du patient **non vulnérable** lors de la visite ou de la consultation.

Lors de visites ou de consultations effectuées par l'IPSPL/CIPSPL sans le médecin, il peut facturer uniquement **le supplément annuel 8875** s'il fait partie d'un GMF.

Si le médecin participe aux services, il peut facturer la visite et les suppléments applicables.

Si la prise en charge du patient a été faite sans le médecin par l'IPSPL/CIPSPL, il pourra facturer la visite de prise en charge et les suppléments applicables à un rendez-vous ou en accès adapté la première fois qu'il verra ce patient, et ce, même s'il a été inscrit antérieurement par l'IPSPL.

Si aucune facture n'a été faite pour un patient, le médecin doit remplir son registre de consultations pour maintenir **l'inscription active**.

Patient vulnérable :

La prise en charge d'un patient vulnérable peut se faire par une IPSPL/CIPSPL. Cependant, les conditions de vulnérabilités ne pourront être ajoutées à l'inscription uniquement lors d'une visite avec le médecin, par le médecin.

Si aucune facture n'a été faite pour un patient vulnérable, le médecin doit **revoir le patient annuellement** pour maintenir l'inscription active.

Il est essentiel d'inscrire la date de l'accident. Vous n'avez pas à joindre une copie du formulaire de CNESST à la demande de paiement.

Pour plus de détail sur les codes de CNESST, veuillez vous référer au manuel de facturation.

CODE	DESCRIPTION
1. Attestation médicale (PAPIER VERT)	
9926	Rédaction et remise sans délai au travailleur du formulaire d'attestation médicale prescrit par la Commission.
2. Rapport sommaire de prise en charge (PAPIER BRUN)	
9927	Rédaction et expédition à la Commission, dans les six (6) jours du premier examen, du formulaire de prise en charge prescrit par la Commission, il s'agit du rapport médical expédié à la Commission par un médecin si la date prévisible de consolidation est de plus de quatorze (14) jours complets après la date où le travailleur est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion
3. Rapport d'évolution (PAPIER BRUN)	
9928	Rédaction et expédition immédiate à la Commission du formulaire d'évolution prescrit par la Commission
4. Rapport final (PAPIER BLEU)	
9930	Rédaction et expédition à la Commission, dès que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée, du formulaire de rapport final prescrit par la Commission
5. Information complémentaire écrite	
9929	Rédaction et expédition à la Commission, dans les dix (10) jours de la réception de la demande, du formulaire d'information médicale complémentaire écrite prescrit par la Commission
6. Bilan médical	
9907	Pour l'information verbale fournie
9914	Considération spéciale en raison de la complexité
9915	Considération spéciale en raison de la complexité
9916	Considération spéciale en raison de la complexité
7. Maintien du lien d'emploi	
9908	Pour l'opinion professionnelle obtenue du médecin
8. Rapport complémentaire	
9909	Rédaction et expédition à la Commission, dans les trente (30) jours de la réception de la demande, du formulaire d'information médicale complémentaire écrite prescrit par la Commission
9. Rapport de consultation motivée	
9910	Rédaction du rapport de consultation motivé et expédition au médecin qui a charge du travailleur
10. Rapport d'évaluation médicale	
9944	Rédaction du rapport de consultation motivé et expédition au médecin qui a charge du travailleur
9901	supplément en neurologie et neurochirurgie, dans le cas de pathologies cérébrales organiques, ou supplément en toxicologie pour les médecins désignés par les parties à l'entente

9978	Examen du travailleur, rédaction et expédition sans délai à la Commission du rapport d'évaluation médicale prescrit
9946	Examen du travailleur dans un délai de un à cinq jours consécutifs suivant la demande de la Commission, rédaction et expédition sans délai à la Commission du rapport d'évaluation médicale prescrit
9947	Considération spéciale en raison de la complexité
9948	Considération spéciale en raison de la complexité
9949	Considération spéciale en raison de la complexité
11. Bureau d'évaluation médicale	
9938	Avis écrit donné au vu du dossier
9939	Avis écrit donné après examen du travailleur
9936	Dossier complexe – Médecin qui participe à la préparation de l'avis commun
9937	Dossier complexe – Honoraires additionnels pour le médecin qui rédige l'avis commun
9981	Considération en raison de la complexité
9982	Considération en raison de la complexité
12. Indemnité	
Compensation équivalente à 40% des honoraires prévus pour l'examen ou l'évaluation médicale à titre de médecin désigné d'un travailleur qui ne se présente pas au rendez-vous. Ne s'applique pas si le temps prévu est comblé par l'examen d'un autre travailleur. (ALIAS #AGOS)	
13. Audiologie	
9919	Supplément pour la production des tests audiologiques
14. Certificat visant le retrait préventif et l'affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite	
9970	Rédaction, remise de la copie à la travailleuse et expédition sans délai du certificat prescrit par la Commission visant l'affectation ou le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite. Inscrire comme date d'accident la date à laquelle le formulaire recommandant le retrait préventif est complété. S'il y a lieu, inscrire un DX de grossesse.
15. Assignment temporaire d'un travail	
9971	Rédaction, remise de la copie au travailleur et expédition sans délai du formulaire d'assignment temporaire prévu par la Commission ou identique à celui-ci
16. Étude de dossier particulier	
9942	Étude de dossier, rédaction et expédition sans délai à la Commission d'un rapport, pour chaque médecin
9911	Considération en raison de la complexité
9912	Considération en raison de la complexité
9913	Considération en raison de la complexité
17. Avis motivé	
9900	Rédaction complète et l'expédition du formulaire d'avis motivé prescrit par la Commission à l'intervenant de la santé qui prodigue les traitements au travailleur, avant la première des deux échéances suivantes : huit (8) semaines de la prise en charge par l'intervenant de la santé ou trente (30) traitements – abolition le 23 mai 2018.
18. Certificat médical du plongeur professionnel	
9954	Rédaction et remise sans délai au travailleur du certificat médical du plongeur professionnel

Codes de médicament et patient d'exception

Code de facturation	Libellé	Tarif (\$)
70017	Demande d'autorisation ou de renouvellement de médicament d'exception transmise à la Régie	36
70018	Demande d'autorisation de patient d'exception transmise à la Régie	80
70019	Demande d'autorisation ou de renouvellement de médicament d'exception transmise à un assureur privé ou à un régime fédéral	36
70020	Demande d'autorisation de patient d'exception transmise à un assureur privé ou à un régime fédéral	80

GAP - lettre d'entente 393

GÉNÉRALITÉS de la nouvelle entente au 1er juin 2024

Offre médicale

- **Les engagements** : Sur une base volontaire, dans leur clinique respective, les MD forment un groupe afin d'inscrire collectivement un nombre de patients en attente du GAMF. Cela est effectif depuis le 1er juin 2022. En tant que groupe, les MD s'engagent à offrir un certain nombre de plages de rendez-vous chaque année pour les patients inscrits collectivement. Ces plages sont réparties sur l'année afin de garantir un accès continu aux soins, aussi bien pour les besoins urgents que pour les suivis réguliers

Les groupes déjà formés continuent d'exister et les engagements pris selon l'ancienne entente (avant le 1er juin 2024, soit la lettre d'entente 368) sont reconduits

- **Répartition trimestrielle** : Chaque trimestre, les MD doivent offrir un nombre minimum de rendez-vous :
 - Du 1^{er} juin au 31 août 2024 : 0,20 plage par patient.
 - Du 1^{er} septembre au 30 novembre 2024 : 0,25 plage par patient.
 - Du 1^{er} décembre 2024 au 28 février 2025 : 0,30 plage par patient.
 - Du 1^{er} mars au 31 mai 2025 : 0,25 plage par patient.
 - **Cas exceptionnel** : Pour le trimestre de juin à août 2024, une offre réduite de 0,15 plage est acceptée pour faciliter la relance des services.

Médecin responsable

- **Qui est responsable ?** Un des médecins du groupe devra être désigné comme médecin responsable. Ce rôle implique de s'assurer que le groupe respecte les engagements (nombre de plages offertes) et de répartir les forfaits entre les médecins du groupe.
- **Pas de rémunération supplémentaire:** Le rôle de médecin responsable n'est pas rémunéré, mais il est essentiel pour le bon fonctionnement du groupe.

MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

- **Les visites suivantes pourront être facturées pour un patient inscrit collectivement (autant en présentiel qu'en téléconsultation) :**

- Visite de suivi vulnérable (lorsque vous jugez que le patient a une condition qui le rendrait éligible à avoir un code de vulnérabilité)
- Visite de suivi non vulnérable
- Intervention clinique

- **Contexte de facturation :**

Lors de la facturation, il faudra indiquer l'élément de contexte "**Patient inscrit en groupe**". Il est toujours de la responsabilité du médecin d'identifier les patients inscrits collectivement.



• **Plan ELITE** : utiliser le contexte #GAP sur les chaque visite de suivi à l'exception de l'intervention clinique

- **Visites sans inscription collective dans la clinique du MD :**

- Si le MD voit un patient lors d'une plage GAP sans qu'il soit inscrit collectivement à sa clinique, il faut facturer la visite selon les modalités habituelles des consultations sans rendez-vous (VPC, VPM ou IC)

- **Forfait pour plage utilisée (code 42267):**

- Un forfait de **50 \$** est disponible pour chaque **plage utilisée**, que ce soit par un patient inscrit collectivement ou un patient référé par le GAP.
- Ce forfait est limité au nombre de plages offertes par le groupe. Si 250 plages sont offertes, mais que seulement 215 sont utilisées, le MD ne pourra facturer que 215 forfaits, soit 10 750 \$ (215 x 50 \$), mais le groupe ne pourra jamais facturer plus de 250 unités de

- ce forfait (le nombre de plages offertes).
- Le forfait doit être facturé à la dernière date du trimestre d'application.

- **Forfait par patient inscrit collectivement (code 42251) :**

- En tant que groupe, le MD peut bénéficier d'un **forfait trimestriel de 12,50 \$** par patient inscrit collectivement prévu à l'engagement (code de facturation **42251**). Ce montant est disponible si le groupe respecte les engagements de services médicaux (une plage par patient inscrit collectivement par an).
- Si le MD offre entre **90 % et 100 %** des plages prévues, il recevra alors une partie du forfait au prorata.
- Le forfait doit être facturé à la dernière date du trimestre d'application.

Exemple

Contexte : Au trimestre du 1^{er} septembre au 30 novembre, vous avez 1 000 patients prévus à l'engagement et l'offre médicale doit être de 0,25 plage par patient, soit 250 plages offertes.

Vous atteignez la cible à 100 % (au moins 250 plages offertes)

Le médecin responsable répartit 1 000 forfaits entre les médecins du groupe selon leur participation :
 $12,50 \text{ \$}/\text{patient} \times 1\,000 = 12\,500 \text{ \$}$.

Vous n'atteignez pas la cible, mais vous avez offert au moins 90 % des plages (minimum 225, mais moins de 250 plages offertes)

Le médecin responsable répartit au prorata les forfaits entre les médecins du groupe. Si vous offrez 225 plages, cela constitue 90 % de l'engagement, soit 900 forfaits : $12,50 \text{ \$}/\text{patient} \times 900 = 11\,250 \text{ \$}$.

Vous n'atteignez pas la cible de 90 % (moins de 225 plages offertes)

Le groupe ne peut pas facturer les forfaits à moins d'avoir été autorisé par le comité paritaire à les facturer au prorata.

- **Comment facturer les forfaits ?**

- Pour facturer les forfaits **42251** et **42267**, il est essentiel que le MD contacte la personne responsable du groupe qui lui dira combien d'unités, il a le droit de facturer pour chacun de ces forfaits.

Refus possibles

Si le groupe n'atteint pas les cibles (moins de 90 % des plages offertes), les forfaits pourront être réduits ou refusés. Il est aussi très important pour les médecins responsables de s'assurer d'avoir les bons chiffres lors de la répartition des unités des forfaits, pour éviter les refus lorsque trop de forfaits sont facturés pour un groupe.

Autres modalités

- **Transfert de patients :** Si un médecin quitte le groupe (retraite, déménagement, etc.), ses patients peuvent être transférés à un autre médecin du groupe ou à l'ensemble du groupe, selon les besoins.
- **Frais de cabinet :** Il est possible de demander une compensation pour les frais de cabinet (**codes 19928** pour 10 patients vus et **19929** pour 20 patients vus sans rendez-vous).

En cas d'absence prolongée

- **Que se passe-t-il en cas de congé prolongé?** Si le MD est en congé (maternité, maladie, etc.), le groupe de médecins doit respecter les engagements (nombre de plages offertes) pour que le MD puisse toucher les forfaits prévus, même s'il n'est pas physiquement présent. Si le groupe atteint ses objectifs, il est considéré comme les ayant atteints également.

Le MD doit indiquer comme **date de service le dernier jour du trimestre d'application**. Toutefois, s'il devient inadmissible ou en congé prolongé en cours de trimestre, il doit facturer ce forfait la veille de l'inadmissibilité ou congé en utilisant l'élément de contexte **Inadmissible à la facturation des forfaits codifiés 42251 ou 42267 à la dernière journée du trimestre en cours**.



Plan ELITE : utiliser le contexte #INAD

FORMATION CONTINUE (annexe XIX)

Le formulaire 3814 est accessible seulement par le [service en ligne](#) de la RAMQ

GÉNÉRALITÉS:

Au moment de transmettre ce formulaire, **vous n'avez pas à faire parvenir à la Régie l'attestation de présence** à une formation dûment signée par le responsable officiel d'une session de formation continue. **Vous devez cependant la conserver pendant cinq ans.** La Régie peut vous la demander en tout temps.

Vous devez réclamer cette allocation forfaitaire dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la formation reçue.

Vous avez droit à sept (7) journées de formation par période de douze (12) mois de pratique active (année civile). Ces journées ne peuvent être utilisées au cours de l'année ou des années subséquentes.

Si vous êtes à honoraires fixes vous pouvez réclamer 10 jours par année. Vous pouvez reporter à l'année suivante et pour cette seule année, le nombre de jours de perfectionnement (ne doit pas dépasser dix (10) jours.

Une session de formation continue dispensée à l'extérieur du Québec est admissible une fois par année. Dans ce cas, le cours de formation continue doit avoir été validé, au préalable, quant à sa durée et à son mérite scientifique, par le Comité consultatif sur la répartition prévu à l'Entente;

Voici le lien de la page de la FMOQ où vous retrouverez le formulaire à compléter, le numéro de téléphone et la démarche à suivre. C'est dans la 2^e section de la page web :

<http://www.fmoq.org/fr/training/policies/allowances/default.aspx>

Ne sont pas considérées comme dispensées à l'extérieur du Québec les sessions de formation qui se tiennent à Ottawa, Campbellton (Nouveau-Brunswick) et dans la province de Terre-Neuve.

Si vous participez à une activité de formation de groupe dans le cadre de la méthode de **l'accès adapté**, vous devez facturer à l'acte avec le code 19739, et si vous êtes médecin formateur le code 19740.

PROCÉDURE AFIN DE REMPLIR LE FORMULAIRE 3814

PROFESSIONNEL		
NOM	PRÉNOM	N° DU PROFESSIONNEL

Nom: nom de famille;

Prénom: prénom usuel;

Numéro du professionnel : numéro d'inscription à la Régie (7 chiffres).

FORMATION CONTINUE										
JOUR	01	02	03	04	05	06	07	PÉRIODE DU		
QUANTIÈME								ANNÉE	MOIS	JOUR
DURÉE (1 jour ou 0,5 jour)								ANNÉE	MOIS	JOUR
ALLOCATION FORFAITAIRE (montant demandé par jour)								MONTANT TOTAL DE L'ALLOCATION FORFAITAIRE		

Quantième:

Date représentée par un nombre à deux chiffres de 01 à 31;

Période:

Dates du début et de la fin de la période couverte par le séjour (AAAAMMJJ);

Durée:

Valeur du jour facturée; 0,5 pour une demi-journée (minimum 3 heures ou 3 crédits) ou 1 pour une journée (minimum 6 heures ou 6 crédits);

Allocation forfaitaire:

Montant réclamé pour une demi-journée (351\$) ou pour une journée (702\$);

Montant total pour l'allocation forfaitaire:

Inscrire la somme des montants réclamés.

LIEU DE LA FORMATION		
<i>Si la formation a eu lieu à Ottawa (Ont.), Campbellton (N.-B.) ou à Terre-Neuve-et-Labrador, veuillez cocher Québec.</i>		
☐ QUÉBEC	NOM DE L'ORGANISME	
☐ HORS DU QUÉBEC	LIEU DE LA FORMATION (ville et province canadienne ou pays étranger)	NUMÉRO D'AUTORISATION ACCORDÉ PAR LE COMITÉ CONSULTATIF SUR LA RÉPARTITION
L'attestation de présence est signée par le responsable officiel de la session de formation continue : ☐ OUI ☐ NON		
Mode de formation : ☐ Webdiffusion ☐ En salle		

Note : Les formations reçues à Ottawa (Ont.), Campbellton (N.-B.) et dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador sont considérées comme étant suivies au Québec.

Québec:

Case à cocher lorsque la formation s'est donnée au Québec;

Nom de l'organisme:

Si la case « Québec » est cochée, choisir le nom de l'organisme agréé. Assurez-vous de la conformité du nom de l'organisme auprès de votre formateur;

Hors du Québec:

Case à cocher lorsque la formation s'est tenue à l'extérieur du Québec;

Lieu de la formation (ville, province ou autre):

Si la case « Hors du Québec » est cochée, vous devez inscrire l'endroit où la formation s'est donnée. Inscrire le nom de la ville ainsi que la province, l'état ou autre;

Numéro d'autorisation accordée par le conseil consultatif FMOQ-MSSS:

Si la case « Hors du Québec » est cochée inscrire le numéro d'autorisation qui paraît sur votre document d'autorisation;

L'attestation de présence est signée par le responsable officiel de la session de formation continue:

Cochez la case « OUI » si l'attestation de présence est signée, sinon, cochez la case « NON »;

Mode de formation:

Case à cocher afin de déterminer si la formation est suivie par Webdiffusion ou en salle.

SÉJOUR DE FORMATION (ANNEXE XII)

Il s'agit de formations de perfectionnement, comme les formations continues, qui s'adressent aux médecins pratiquant en régions éloignées (Territoires de couleur, autre que beige sur cette carte : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2003/03-913-07.pdf>).

Tout médecin qui bénéficie de ces mesures prévues (ressourcement) à l'annexe XII de l'Entente a droit à un maximum de 20 jours par période de 12 mois durant lesquels il a exercé sa profession dans ces territoires.

La procédure complète sera fournie sur demande.

Si nous faisons la réclamation pour vous, veuillez nous transmettre l'attestation de présence et mentionner le nombre de jours à réclamer. Si vous vous êtes déplacé pour votre séjour de formation, les pièces justificatives originales sont requises.

Exemple : stationnement, reçu de taxi, billet d'avion (exceptionnellement la Régie acceptera une impression du billet électronique) et autres et mentionner le jour avant et après à réclamer.

FACTURATION HORS-RAMQ

GUIDE DE FACTURATION PRIVÉE OMNIPRATICIEN

Voici l'information pertinente pour être en mesure de récolter la bonne information lorsque vous voyez des patients non couverts par la RAMQ afin de vous assurer un paiement pour les services rendus. De plus, vous y verrez quelques conseils selon le type de facturation.

Prendre note que nous offrons les services de réclamation pour la facturation privée. Veuillez vous référer à l'agence de facturation afin de connaître le tarif pour toute réclamation.

LORSQUE VOUS NOUS TRANSMETTEZ L'INFORMATION, IL EST IMPORTANT D'AVOIR LE NOM COMPLET, LA DATE DE NAISSANCE, LE DIAGNOSTIC, L'ÉTABLISSEMENT OÙ LE PATIENT A ÉTÉ VU, LA PLAGE HORAIRE OU L'HEURE EXACTE ET NOM DU MÉDECIN QUI A VU LE PATIENT.

Prendre note que le délai de paiement pour les types de facturation hors-RAMQ est de 3 mois à 1 an.

CNESST

Tous les actes, formulaires, visites, chirurgies effectués en lien avec un accident de travail doivent être facturés à la RAMQ. Veuillez fournir la date d'accident.

Si vous avez le plan ELITE, vous devez facturer le patient sans NAM en sélectionnant la situation « patient requiert des soins urgents ». Ne pas oublier d'inscrire une date d'accident dans la case date d'événement.

ASSURANCE

Délai de réclamation : 12 mois

Information requise : numéros de contrat, certificat et le nom de la compagnie

MILITAIRE

Délai de réclamation : 12 mois

Information requise : numéro matricule et date de naissance.

No téléphone de la Croix-Bleue : 1-888-260-4033

Lien utile : <https://www.medaviebc.ca/fr/professionnels-de-la-sante/resources>

DÉTENU

Délai de réclamation : 12 mois

Information requise : centre de détention et date de naissance (*Centre de détention Fédéral seulement*).

IMMIGRANT

Délai de réclamation : 6 mois

Information requise : numéro d'identification à 8 chiffres ou 10 chiffres (**ID ou ICU**) et date de naissance

No téléphone de la Croix-Bleue: 1-888-614-1880

Lien utile : <https://www.medaviebc.ca/fr/professionnels-de-la-sante/resources>

HORS PROVINCE

Délai de réclamation : 12 mois sauf la province de la Nouvelle-Écosse (6 mois) et la province de la Colombie-Britannique (6 mois pour les patients hospitalisés et 90 jours pour les patients vus à l'externe et en cabinet)

Information requise :

1 - Formulaire original signé par le patient aucune photocopie n'est acceptée. Pour le Nouveau-Brunswick, il n'est pas nécessaire d'avoir le formulaire signé, par contre il faut l'adresse complète. Formulaire Hors-Province : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/2688.pdf>

2 - Numéro de la carte santé

Ontario : 10 chiffres

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/ohip/sob/physserv/sob_master11062015.pdf

Nouveau Brunswick : 9 chiffres

Colombie Britannique : 10 chiffres

Saskatchewan : 9 chiffres

Terre-Neuve : 12 chiffres

Alberta : 9 chiffres

Manitoba : 6 chiffres

Nouvelle-Écosse : 10 chiffres

Île-du-Prince-Édouard : 8 chiffres

Territoires-Du-Nord-Ouest : une lettre et 7 chiffres

3 - Le nom de la province.

SAAQ

-Rapport initial : 30 \$

-Rapport d'évaluation : 80 \$

-Rapport d'évolution : 80 \$

-Rapport de séquelles : 75 \$

PARTICULARITÉ POUR LES BÉBÉS

- **Militaire**

Si l'un des parents a un Nam RAMQ ont peut le réclamé avec celui-ci a la RAMQ sinon il doit payer les frais médicaux.

- **Immigrant**

Les parents doivent communiquer avec le service des citoyens afin de fournir s'il y a lieu l'admissibilité du bébé à la Régie, sinon, ils devront payer les frais médicaux et s'il y a lieu se faire rembourser.

- **Hors province**

Si le bébé n'a pas de numéro de carte santé, ils devront payer les frais médicaux et se faire rembourser dans leur province.

AUCUNE COUVERTURE SANTÉ

Vous pouvez demander au patient de vous payer directement votre partie d'acte professionnel lors de la visite. Nous n'agissons pas à titre de collection directement chez un patient.

PEUPLES AUTOCHTONES

Peu importe la réserve, celui-ci doit avoir un numéro de carte santé de la province

GRILLE PROVINCIALE DES TARIFS POUR LES SERVICES NON ASSURÉS, LES SERVICES DÉASSURÉS ET LES FRAIS CONNEXES EFFECTUÉS PAR DES MÉDECINS DE FAMILLE

Ces tarifs sont suggérés par la FMOQ
Les taxes exigibles sont en sus

Pour obtenir la version la plus récente de cette grille :

[HTTPS://WWW.FMOQ.ORG/PRATIQUE/FACTURATION/FRAIS-ACCESSOIRES/GRILLE-TARIFAIRE-ET-AFFICHAGE-DES-FRAIS-ADMISSIBLES/](https://www.fmoq.org/pratique/facturation/frais-accessoires/grille-tarifaire-et-affichage-des-frais-admissibles/)

ANNEXE 3 – Procédures pour le plan élite

FORFAIT SUPERVISION

Codes de facturation :

Résident et externe : 19910, 19911, 19912, 19913, 19914, 19915, 19916, 19917, 19918, 19919, 19920, 19921

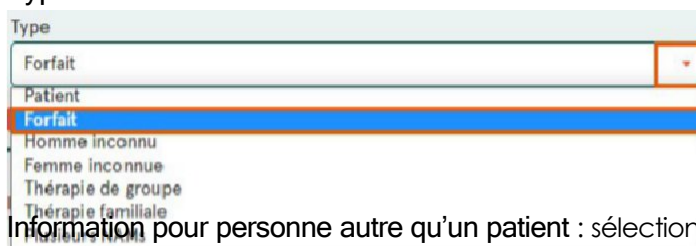
IPS (étudiante) : 19922, 19923, 19924, 19925, 19926, 19927

Sage-femme (étudiante) : 19907, 19908

INSTRUCTION DE FACTURATION –GRILLE DE FACTURATION ET FACTURE

** Faire une facture par type de supervision. Par exemple, vous ne pouvez mettre un résident et un externe sur la même facture ou ligne si vous faites votre facturation dans une grille.

Type : forfait



The screenshot shows a dropdown menu with the label 'Type'. The options listed are: Forfait (highlighted in blue), Patient, Homme inconnu, Femme inconnue, Thérapie de groupe, Thérapie familiale, and Autres soins. The 'Forfait' option is selected.

Information pour personne autre qu'un patient : sélectionner le type approprié (résident, externe, sage-femme...)

INFORMATIONS ADDITIONNELLES



The screenshot shows the 'INFORMATIONS ADDITIONNELLES' section. It has a label 'Information pour personne autre qu'un patient' and a dropdown menu with 'Résident' selected. Below this is a label 'Numéros' and a text input field.

Numéro : inscrire le(s) numéro(s) de pratique des personnes supervisées. S'il y en a plus d'un, les séparer par une virgule sans espace.

- Externe : E majuscule suivi de 8 chiffres (E12345678)
- Résident : Remplacer le R par le chiffre 5 suivi de 5 chiffres (5XXXXXX)
- Infirmière IPS (étudiante): 8XXXXXX (ou plus rarement 4XXXXXX)
- Sage-femme (étudiante) : 93XXXX

Heure : Indiquer l'heure de début du service (08h-12h-16h-20h-24h-04h ou l'heure exacte du début de la période.



The screenshot shows the 'LIGNES DE FACTURE' section. It has a label 'Début' and a dropdown menu. Below this is a text input field, a search icon, a list icon, and an 'Ajouter' button.

Code : Code de supervision : nombre de résidents, d'externes ou d'IPS (étudiante) par demi-journée.

Exemple : Un médecin supervise 2 résidents en AM et PM et pour son lieu de pratique, il doit utiliser le code 19910. Il devra faire 2 lignes dans sa facture en inscrivant: 19910:2 en AM et 19910:2 en PM en précisant l'heure de début de la supervision de chaque plage horaire.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement

AJOUT D'UN PROFESSIONNEL RÉFÉRANT

Lorsque vous devez entrer un professionnel référent, assurez-vous d'avoir le numéro de celui-ci ainsi que son nom. Il est important de l'ajouter à votre facturation lorsqu'il est requis.

Dans l'onglet du professionnel référent vous devez inscrire le numéro du professionnel (dans le cas des médecins, des résidents, des externes, des IPS et IPSPL ainsi que les sages-femmes).

Advenant que le numéro ne soit pas disponible, voici la procédure à suivre :

- Dans la facture ou la grille de facturation, cliquer sur l'icône à droite de professionnel référent

Nouveau professionnel référent

- Cliquer sur en haut à gauche
- Cliquer sur NO. LICENCE INCONNU ☒
- Compléter les champs d'identification du référent
- Sélectionner la profession appropriée
- Cliquer sur Sauvegarder et sélectionner (*)

ÉCHANGE INTERDISCIPLINAIRE

Voici la procédure à suivre pour facturer l'échange interdisciplinaire selon le nombre de patients discutés.

UN SEUL PATIENT

Type : Patient

Raccourci : EIP

Codes : 15620, 15643, 15652, 15631, 15914, 15917

Inscrire la durée en minute

Ex : 15620:15

Type	NAM
Patient	

PLUSIEURS PATIENTS

Type : Plusieurs NAMs

Raccourci : EIPA

Codes : 15620A, 15643A, 15652A, 15631A, 14914A, 15917A

Inscrire la durée en minute

Ex. : 15620A:15

Type
Plusieurs NAMs

Liste de NAMs

i Vous pouvez ajouter plusieurs NAMs en les séparant par des virgules.

NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE EXPIRE OU PATIENT SANS NAM

Lorsqu'un patient ne présente pas sa carte d'assurance maladie ou que sa carte est expirée, il **doit généralement payer pour les services médicaux qu'il reçoit**. Il y a cependant quelques exceptions qui vous permettraient de facturer les services à la Régie et non au patient. Vous pouvez retrouver les exceptions dans le tableau plus bas.

Pour tous les autres cas de figure, afin que la personne assurée puisse obtenir le remboursement du montant qu'elle a payé au médecin, ce dernier doit remplir avec le patient le formulaire **papier #4314** « Demande de remboursement d'une personne assurée ».

SOINS NON URGENTS

Si le NAM du patient est expiré, le patient doit payer les services rendus à l'aide du formulaire 4314.

Pour le médecin ayant le plan avec l'option saisie, veuillez nous indiquer le montant que vous avez perçu. Pour le médecin ayant le plan ÉLITE, veuillez vous rendre sur Facturation.net et suivre les étapes suivantes :

Étape 1 : Créer une facture et cocher la case « Remboursement pers. assurée (4314) ».

Statut: Nouveau	En attente	Remboursement pers. assurée (4314)
Médecin	Code de service	Facturation

Étape 2 : Une fois que votre demande est bien remplie, sauvegarder et envoyer à la RAMQ, vous devez prendre en note le RAMQ Id.

Étape 3 : Vous devez fournir le « RAMQ id » au patient, car il devra indiquer ce numéro dans son formulaire de réclamation dans la case « numéro de facture RAMQ ». Voici l'endroit où le numéro doit être inscrit dans le formulaire #4314.

Régie de l'assurance maladie Québec

Demande de remboursement d'une personne assurée

Numéro de facture RAMQ

SECTION DU PROFESSIONNEL

1. Renseignements sur le professionnel

Nom de famille Prénom Numéro du professionnel

2. Renseignements sur la personne assurée

Nom de famille à la naissance Numéro d'assurance maladie

Prénom à la naissance Date de naissance Année Mois Jour Sexe ☐ M ☐ F

Il est très important d'inscrire ce numéro dans le formulaire, car le patient ne sera pas remboursé si cette information est manquante.

IMPORTANT ! Si la facture n'est pas faite sur Facturation.net 2.0 le même jour que la date de service de la demande, la RAMQ refuse avec le message d'erreur suivant :

[RAMQ] Toute facture liée à une demande de remboursement soumise après la date de service doit contenir le montant perçu.

Voici la procédure spécifique à suivre pour cette situation :

Après avoir créé votre facture de type « remboursement d'une personne assurée (4314) » et ajouter le ou les codes d'actes:

- Entrez dans la ligne ou les lignes de facture

LIIGNES DE FACTURE INFORMATION S ADDITIONNELLES LAISSER UNE NOTE AU RESPONSABLE

Debut 00:00

Line Number	Date	Statut	Debut	Code d'acte	Ressource	Rôle	Unité	# contestes	Montant perçu	Montant payé	Supprimer
No. de ligne 1	2021-08-26		08:00	15766		1			0,00 \$	0,00 \$	☐
									Total 0,00 \$	Total 0,00 \$	

- Inscrivez le montant perçu dans la case « Montant perçu » et appuyez sur « OK »

Éditer l'acte (Période de facturation: 0)

Code d'acte
15766

Raccourci

Consultation, examen et visite / Visites sans rendez-vous, ou sur rendez-vous pour un patient non inscrit (patient de moins de 80 ans inscrit ou non inscrit) / Patient non vulnérable / Visite ponctuelle mineure / Clientèle inscrite de 500 patients ou plus / En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet OU En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U

Rôle
1 - Médecin responsable de l'acte ou méde:

Date de service
2021-08-26

Début
08:00

Fin / 1 - 1

Contexte spécifique

☐ 223E - Pour déterminer si une ordonnance de suspension d'instance devrait être rendue en vertu de l'article 672.851 du Code criminel, dans le cas où un verdict d'innocence à subir son procès a été rendu à l'égard de l'accusé

☐ 223C - Pour déterminer la décision qui devrait être prise dans le cas où un verdict d'innocence à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l'égard de l'accusé

Montant perçu
80,00

Formule de paiement

OK

- Le montant perçu va ensuite apparaître sur la ligne de facture et sera transmis à la RAMQ lors de la sauvegarde

Line Number	Date	Statut	Début	Code d'acte	Raccourci	Rôle	Unités	# contacts @	Montant perçu	Montant payé	Supprimer
No. de ligne: 1	2021-08-26		08:00	15766		1	0		80,00 \$	0,00 \$	☐
									Total 80,00 \$	Total 0,00 \$	

Pour éviter des refus sur des états de compte, il est important que l'utilisateur s'assure que le montant perçu correspond au montant qui a été inscrit sur le formulaire de demande de remboursement d'une personne assurée (4314). Nous avons d'ailleurs ajouté un « i » informatif à côté de la case « Montant perçu » avec cette information.

Le patient dont la carte RAMQ est expirée peut demander une autorisation temporaire de couverture à la RAMQ en appelant aux numéros suivants :

- Québec 418 646-4636
- Montréal 514 864-3411
- Ailleurs au Québec 1 800 561-9749

SOINS URGENTS

Si le patient ne peut présenter sa carte d'assurance ou sa carte est expirée, cliquez dans le dossier bleu à droite du NAM.

Une fois dans le dossier, vous devrez laisser la case **PAS DISPONIBLE** cochée puis compléter le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe du patient avant de sauvegarder. La situation du patient se mettra par défaut à *patient requérant des soins urgents* dans la facture.

FACTURATION D'UN ASSURÉ SANS CARTE RAMQ

Lorsqu'une personne assurée est dans l'impossibilité de présenter sa carte d'assurance maladie, le médecin omnipraticien peut facturer ses services à la RAMQ dans les circonstances ci-dessous. En plus d'inscrire les renseignements sur le patient, le médecin omnipraticien doit indiquer la circonstance dans laquelle il a rendu les services.

Circonstances	Informations à fournir
L'enfant est âgé de moins d'un an	Inscrire : 1. le nom, prénom, la date de naissance, le sexe et l'adresse (si connue); 2. le numéro d'assurance maladie de la mère ou du père (lorsque connu) 3. l'ordre des naissances (naissances multiples)
La personne est dans un état requérant des soins urgents.	Si les informations d'identité sont connues, inscrire : 4. le nom, prénom, date de naissance, le sexe et l'adresse (si connue) 5. le numéro d'assurance sociale, si connu
La personne assurée est admise dans un centre de réadaptation ou dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée	Inscrire le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et l'adresse
La personne assurée est un mineur de 14 ans ou plus qui reçoit des services couverts sans l'autorisation parentale.	Inscrire le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et l'adresse
La personne fait l'objet d'une ordonnance du tribunal pour l'évaluation de son état mental et ne peut pas présenter une carte d'assurance maladie valide à la date du service	Inscrire le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe
Services professionnels à la demande du coroner	Inscrire le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe Ne rien inscrire si le cadavre est non identifiable
Prélèvement d'un donneur non québécois	Inscrire le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et l'adresse